**QUESTÃO 01** **SEMUSA (SMS) Macaé • 2026**

Gabarito: **C**

Durante o atendimento no ambulatório de ginecologia de nosso programa de residência médica você recebe uma paciente de 48 anos queixando se de que não menstrua há 3 meses e sente fortes ondas de calor em pescoço e cabeça, principalmente à noite. Refere ainda que há 5 dias apresentou sangramento genital de forte intensidade com acontecimento de lipotímia subsequente. Ela traz exames de laboratório solicitados por outro colega que mostram: FSH = 87,57 mUI/mL (normal de 3,5 mUI/mL à 134,8 mUI/mL), estradiol = 44,65 pg/mL (normal de 12,5 pg/mL à 498 pg/mL). Ultrassonografia transvaginal mostra miométrio e ovários normais e endométrio homogéneo com 12 mm. Sobre este caso analise as alternativas abaixo: I. As dosagens de FSH e estradiol confirmam menopausa. II. Esta paciente ainda possui alguns folículos terciários produzindo estradiol. III. Para cessar o sangramento metrorrágico indica-se anticoncepcional hormonal oral combinado monofásico, 1 comprimido via oral de 8 em 8 horas, durante 1 semana. Sobre esta situação selecione a opção correta:

**A** As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.

**B** As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.

**C** As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa. ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

**D** As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

**E** As afirmativas I, II e III são falsas.

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA C**

**QUESTÃO 02** **Afya Centro Universitário de Araguaína - UNITPAC • 2026**

Gabarito: **A**

Uma mulher de 42 anos, G2P2, procura atendimento ambulatorial por sangra mento uterino irregular há cerca de 6 meses, caracterizado por ciclos imprevisíveis, com epi sódios de sangramento prolongado e aumento do volume menstrual. Refere fadiga progressiva, mas nega dor pélvica, dispareunia ou perda ponderal. Não faz uso de anticoncepcionais hormonais. Ao exame ginecológico, apresenta colo uterino sem lesões visíveis, útero de tamanho normal e sem dor à mobilização. O exame especular é normal. A ultrassonografia transvaginal evidencia endométrio espessado e heterogêneo medindo 14 mm, sem massas anexiais. O hemograma revela hemoglobina de 9,6 g/dL. O teste de gravidez é negativo. Considerando o quadro clínico, a faixa etária e os achados ultrassonográficos, qual é a conduta inicial mais adequada?

**A** Iniciar contraceptivo oral combinado para controle do sangramento. ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

**B** Introduzir ácido tranexâmico durante os episódios de sangramento.

**C** Solicitar histeroscopia diagnóstica com biópsia endometrial.

**D** Prescrever progestagênio contínuo e reavaliar em 6 meses.

**E** Indicar ablação endometrial como trata mento definitivo.

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA A**

**QUESTÃO 03** **Faculdade de Medicina Nova Esperança • 2026**

Gabarito: **C**

Sangramento uterino anormal (SUA; termo que se refere ao sangramento uterino de quantidade, duração ou frequência anormais) é uma preocupação ginecológica comum em mulheres em idade reprodutiva. O SUA pode ser causado por:

**A** Patologias estruturais uterinas (por exemplo, miomas, pólipos endometriais, adenomiose, neoplasia, síndrome de Rokitansky).

**B** Causas não uterinas (por exemplo, disfunção ovulatória, distúrbios de hemostasia, medicamentos, síndrome de Morris).

**C** Doenças em qualquer local anatômico do trato genital inferior (colo do útero, vagina, vulva) ou superior (corpo uterino, trompas de Falópio, ovários). ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

**D** Gestações no primeiro trimestre (25% até 13+6 semanas - ou seja, 13 semanas mais 6 dias de gestação datados do primeiro dia do último ciclo menstrual). É muito menos comum no segundo trimestre (14+ 0 a 27+6 semanas), ocorrendo em 1 a 2% das gestações.

**E** Imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano (HPO) é a causa mais comum de sangramento uterino anovulatório em adolescentes.

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA C**

**QUESTÃO 04** **AFAMCI - Hospital dos Plantadores de Cana (RJ) • 2026**

Gabarito: **A**

Qual é o método padrão-ouro para diagnóstico de patologia intracavitária uterina causadora de SUA (sangramento uterino anormal) estrutural?

**A** USG via transvaginal. ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

**B** Histeroscopia.

**C** Colposcopia com biópsia.

**D** Curetagem uterina.

**E** Ressonância magnética.

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA A**

**QUESTÃO 05** **IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais • 2026** Gabarito: **D**

O sistema de classificação PALM-COEIN, desenvolvido pela FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia), padroniza as etiologias do Sangramento Uterino Anormal (SUA) em componentes estruturais (PALM) e não estruturais (COEIN). Sobre a correta categorização das causas de sangramento neste sistema, registre V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. (__)A Coagulopatia (C) é uma causa classificada como não estrutural, sendo a Doença de von Willebrand uma das etiologias mais prevalentes em adolescentes com sangramento menstrual intenso desde a menarca. (__)A Adenomiose (A) é classificada como uma causa estrutural (PALM), caracterizada pela presença de glândulas e estroma endometrial no miométrio, cujo diagnóstico pode ser sugerido por critérios ultrassonográficos ou de ressonância magnética. (__)Os Pólipos endometriais (P) são classificados no grupo das causas não estruturais (COEIN), pois representam um crescimento funcional do endométrio que não altera a anatomia da cavidade uterina. (__)O Leiomioma (L) é subdividido em submucoso e outros, sendo que os leiomiomas subserosos são os principais responsáveis pelo sangramento uterino anormal devido à sua grande superfície de contato com o endométrio. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

**A** V, F, V, F.

**B** F, V, F, V.

**C** V, V, F, F.

**D** V, V, V, F. ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA D**

**QUESTÃO 06** **SES-DF - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal • 2026** Gabarito: **C**

Uma paciente de 25 anos de idade procurou atendimento por sangramento uterino irregular há quatro meses, com intervalos variáveis entre 15 e 45 dias, acompanhado de fluxo aumentado. Negou uso de anticoncepcionais, histórico de doenças crônicas ou gestação. O exame físico não mostrou alterações relevantes. Os exames laboratoriais revelaram: Beta-hCG negativo, Hemograma: Hb = 11,2 g/dL. A ultrassonografia transvaginal mostrou útero de volume normal, endométrio com 11 mm na fase tardia do ciclo, sem pólipos ou miomas visíveis. No caso clínico apresentado, qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

**A** Sangramento uterino anovulatório por disfunção ovulatória.

**B** Miomatose uterina submucosa.

**C** Síndrome de Asherman. ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

**D** Adenomiose difusa.

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA C**

**QUESTÃO 07** **SES-DF - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal • 2026** Gabarito: **C**

Uma paciente de 25 anos de idade procurou atendimento por sangramento uterino irregular há quatro meses, com intervalos variáveis entre 15 e 45 dias, acompanhado de fluxo aumentado. Negou uso de anticoncepcionais, histórico de doenças crônicas ou gestação. O exame físico não mostrou alterações relevantes. Os exames laboratoriais revelaram: Beta-hCG negativo, Hemograma: Hb = 11,2 g/dL. A ultrassonografia transvaginal mostrou útero de volume normal, endométrio com 11 mm na fase tardia do ciclo, sem pólipos ou miomas visíveis. Qual alteração fisiopatológica é mais comum nesses casos?

A Redução da produção hipotalâmica de GnRH.

B Falha na seleção e dominância folicular, levando à anovulação persistente.

C Aumento da atividade dopaminérgica. ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

D Excesso de FSH na fase folicular.

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA C**

**QUESTÃO 08** **HUSE - Hospital de Urgência de Sergipe Gov. João Alves Filho • 2026** Gabarito: **C**

Paciente, 36 anos, tabagista, com histórico de enxaqueca com aura, procura serviço de urgência por apresentar sangramento genital em grande quantidade há 5 dias. Ao exame especular observa-se sangramento exteriorizando-se pelo orifício externo do colo do útero. Realizado B-HCG que deu negativo. Foi realizado acesso venoso para reposição hipovolêmica com infusão de cristalóides e ácido tranexâmico venoso. Após estabilização do quadro, dentre as opções listadas abaixo, qual a melhor opção terapêutica para a paciente utilizar após a alta?

A Etinilestradiol 30mcg + levonorgestrel 150mcg, um comprimido, 3 vezes ao dia, até parar o sangramento. Após um comprimido ao dia por 4 semanas.

B Etinilestradiol 20mcg + levonorgestrel 150mcg, um comprimido, 3 vezes ao dia, até parar o sangramento. Após um comprimido ao dia por 4 semanas.

C Implante de etonogestrel. ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

D Noretisterona 5 a 15 mg/dia até parar o sangramento. Após 5 a 10 mg/dia durante 3 a 6 semanas.

E Acetato de medroxiprogesterona 150mg, IM, a cada 12 semanas.

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA C**

**QUESTÃO 09** **HEDA - Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (PI) • 2026** Gabarito: **A**

Antônia 44 anos relata menorragia crônica, com ciclos menstruais prolongados apresentando sangramento intenso por cerca de 11 dias, de forma recorrente há mais de seis meses. Ao exame ginecológico, observa-se útero aumentado de volume, móvel e de contornos regulares. A ultrassonografia pélvica evidencia miomatose uterina, com miomas intramurais e subserosos, sendo o maior medindo 5 cm. Como parte do tratamento clínico, foi indicada a inserção de dispositivo intrauterino liberador de progesterona. Assinale a alternativa que corresponde ao principal objetivo terapêutico dessa conduta:

**A** Diminuir o aporte sanguíneo arterial para o útero. ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

**B** Inibir a ovulação por supressão do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano.

**C** Induzir regressão volumétrica dos leiomiomas uterinos.

**D** Promover atrofia funcional do endométrio.

**E** Reduzir a produção ovariana de estrogênio circulante.

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA A**

**QUESTÃO 10** **CEPOA - Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados (RJ) • 2026** Gabarito: **A**

Mulher de 43 anos com sangramento uterino súbito e intenso, hipotensa, sem gestação. Ao exame, útero aumentado e doloroso. Qual a conduta inicial?

**A** Histerectomia de urgência. ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

**B** Ultrassonografia pélvica ambulatorial.

**C** Reposição volêmica e estabilização.

**D** Prescrever antifibrinolítico oral.

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA A**

**QUESTÃO 11** **Centro Universitário Atenas • 2025** Gabarito: **C**

Mulher, 29 anos de idade, 2G2PC, comparece ao serviço de ginecologia com Sangramento Uterino Anormal (SUA). Nega comorbidades ou uso de medicamentos. Exame físico sem alterações. Segue a imagem da ultrassonografia transvaginal.

Considerando a classificação da FIGO em relação ao Sangramento Uterino Anormal - SUA (PALM-COEIN), qual é o diagnóstico mais provável?

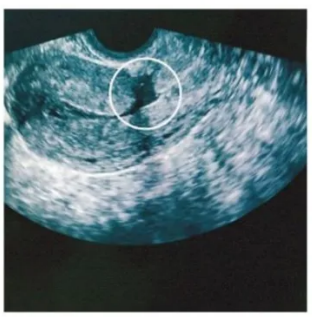


*Figura: Ultrassonografia pélvica transvaginal (corte sagital uterino)*

**A** SUA-A.

**B** SUA-L.

**C** SUA-N. ✓ GABARITO DA PLATAFORMA

**D** SUA-M.

**E** A classificação da FIGO não pode nunca ser utilizada para Sangramentos Uterinos Anormais.

GABARITO APONTADO NA PLATAFORMA: **ALTERNATIVA C**